ONEMA-POP-031 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-031 — Monitoramento da Insuficiência Cardíaca Crônica e Reconhecimento de Congestão/Deterioração

1. Identificação institucional

983558 | Data: 09/11/2026.

2. Objetivo e abrangência

Padronizar monitoramento da insuficiência cardíaca crônica e reconhecimento de congestão/deterioração na atuação da rede ONEMA ONE, com avaliação, execução segura, continuidade e escalonamento. Aplicável ao atendimento domiciliar e, quando pertinente, digital; não substitui decisões médicas nem suporte de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Execução e julgamento clínico por enfermeiro habilitado, conforme competências e treinamento. Indicações: Pessoas com insuficiência cardíaca diagnosticada, estáveis ou com suspeita de congestão; não realizar monitoramento eletivo se houver instabilidade. Contraindicações operacionais: ausência de consentimento ou de condições seguras, urgência incompatível com atendimento eletivo, ou ação fora da competência/prescrição.

4. Materiais, equipamentos e fornecimento

Enfermeiro: esfigmomanômetro validado, estetoscópio, oxímetro, termômetro e ficha de evolução. Paciente: balança confiável, lista de medicamentos e plano terapêutico. Em visitas presenciais, o profissional dispõe de aparelho de pressão validado, estetoscópio, termômetro e oxímetro; utilizar conforme avaliação. Insumos específicos são providenciados pelo paciente/responsável, salvo acordo contratual.

5. Avaliação clínica e preparo

Peso de referência e tendência, dispneia habitual e atual, ortopneia, edema, diurese, fadiga, PA/FC/SpO2 conforme contexto, adesão e mudanças recentes. Confirmar identidade, consentimento, privacidade, ambiente e plano prévio; estabelecer linha de base e reconhecer urgências antes de iniciar.

6. Execução técnica numerada

1. Confirmar diagnóstico, classe funcional quando conhecida, plano médico, peso de referência e contatos de retaguarda.

2. Perguntar sobre falta de ar em repouso, ao esforço e ao deitar; número de travesseiros, despertares noturnos e dor torácica.

3. Comparar pesos medidos em condições semelhantes e verificar tendência de aumento, sem usar isoladamente um limiar universal.

4. Inspecionar edema, esforço respiratório, perfusão e nível de consciência; aferir sinais vitais na visita.

5. Conferir medicamentos em uso e possíveis omissões, sem ajustar diurético ou outros fármacos sem prescrição/plano

formal.

6. Classificar deterioração: sinais de edema pulmonar, hipoxemia, síncope ou dor torácica exigem emergência; congestão

progressiva exige avaliação médica breve.

7. Comunicar achados objetivos à equipe responsável e registrar confirmação do encaminhamento.

8. Reforçar monitoramento de peso e sintomas, adesão e restrições individualizadas já prescritas.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Dispneia intensa em repouso, confusão, cianose, síncope ou dor torácica: SAMU 192. Agravamento progressivo:

avaliação médica no mesmo dia conforme gravidade. Em emergência, acionar SAMU 192 e registrar horário e

destinatário; não retardar atendimento por registro digital.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar registro diário de peso quando indicado, reconhecer ortopneia/edema e não alterar dose de diuréticos por conta

própria. Confirmar compreensão por retorno verbal e definir quem será contatado em caso de piora.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa, histórico e avaliação, sinais vitais pertinentes, diagnósticos

e plano de Enfermagem, passos executados e não executados com justificativa, resposta clínica, intercorrências,

orientações, contatos e encaminhamentos, profissional responsável e assinatura/trilha de auditoria.

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

 AHA/ACC/HFSA — 2022 Guideline for the Management of Heart Failure —

https://professional.heart.org/en/science-news/2022-aha-acc-hfsa-guideline-for-the-management-of-heart-failure

 COFEN, Resolução nº 736/2024 — Processo de Enfermagem —

https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/